Reporte y análisis

Finalidad y momento de uso

Registrar reporte y análisis en el momento de la actividad correspondiente a ODO-PP29. No usar datos simulados ni declarar ejecución únicamente por disponer del formato.

Responsabilidad y preparación

La persona que realiza la actividad registra datos reales; el verificador revisa coherencia y evidencia según rol. Reunir instrucciones y soportes necesarios, confirmar identidad del objeto o usuario y usar acceso autorizado.

Fecha / proceso / usuario codificado

Identificar de manera inequívoca el objeto o usuario del registro. En controles administrativos usar código y ubicación reservada del soporte; verificar identidad antes de decisiones clínicas o entrega.

Hecho / daño / atención inmediata

Diligenciar dato concreto y pertinente a reporte y análisis. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

Cronología y evidencia

Identificar documento auténtico, versión, origen y ubicación accesible al autorizado. La plantilla no sustituye licencia, manual original, certificado técnico ni prueba de ejecución.

Barreras fallidas / factores

Diligenciar dato concreto y pertinente a reporte y análisis. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

Reportes externos si aplican / radicado

Diligenciar dato concreto y pertinente a reporte y análisis. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

Acción / responsable / plazo

Identificar persona y rol que ejecuta o verifica, no solamente cargo genérico. Asociar autenticación válida cuando la naturaleza del registro la exige y proteger permisos de acceso.

Formato para diligenciar

Documento asociado: ODO-PP29 | Registro en blanco. Adjuntar hojas adicionales identificadas si se requiere.

Campo	Registro
Fecha / proceso / usuario codificado	
Hecho / daño / atención inmediata	
Cronología y evidencia	
Barreras fallidas / factores	
Reportes externos si aplican / radicado	
Acción / responsable / plazo	
Verificación y cierre	

Observaciones y soporte vinculado

_____

_____

_____

Criterios de revisión y custodia del registro

Condiciones de entrada

Confirmar usuario, antecedentes, alergias, medicación, motivo y cambios clínicos. Relacionar indicación con diagnóstico y alcance de este documento. Verificar competencia, guía completa adoptada, equipos/insumos y ruta para complicaciones; si el riesgo supera capacidad, coordinar remisión.

Decisión y preparación

Individualizar plan, sitio y técnica; informar riesgos y alternativas y vincular aceptación específica. Revisar instrumental liberado, productos vigentes y medidas de aislamiento. La decisión clínica requiere fundamento y no se deriva de una lista administrativa.

Registro de ejecución

Describir lo observado y realizado en secuencia cronológica, con diente/sitio, técnica, medicamentos, materiales y lotes pertinentes. Documentar cambios de plan, eventos y acciones, vinculando registros de carga/paquetes. Evitar frases como sin novedad cuando hubo un hallazgo relevante.

Registro no satisfactorio

Registrar la diferencia, proteger el área/usuario/material según riesgo y avisar al responsable. Establecer acción, plazo y comprobación posterior. En reprocesamiento una carga no conforme no se libera por urgencia de agenda.

Archivo y correcciones

Identificar fecha, autor, versión y ubicación de anexos. Corregir por adenda o registro trazable sin borrar original. Custodiar con reserva si contiene datos de salud y asociar autenticación legalmente válida donde corresponda. El diseño no incluye campos de firma.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609